

BBN - Annonce de mauvaise nouvelle

EPICES :

E – Environnement

Préparation de l'environnement extérieur et intérieur :

- Préparation du soignant
- Connaissance du dossier
- Anticiper le déroulement de l'entretien: la personne qui initie, la durée

Contexte :

- Choix d'un lieu calme, disposition adaptée (en rond, éviter grandes tables)
- Préparation du patient
- Présence de proche(s) significatif(s)
- Communiquer le moment et la durée de l'entretien

P – Perception du patient

Identifier ce que sait déjà le patient sur sa maladie et l'impact qu'elle aura sur son avenir: niveau de compréhension, le mode d'expression, l'état émotionnel

- *Pouvez-vous nous dire ce que vous avez compris jusqu'à présent de votre situation?*
- *Pouvez-vous nous décrire comment vous vivez votre maladie en ce moment ?*
- *Quelles informations avez-vous déjà reçues ?*
- *Quelles sont les informations qui vous ont été transmises, jusqu'à présent ?*
- *Savez-vous pour quelle raison cet examen a été réalisé ?*

I – Invitation

Adapter le niveau de transmission selon le rythme et le souhait du patient: il s'agit de déterminer le niveau d'information que le patient souhaite connaître

- *Qu'aimeriez-vous savoir à propos de ce qui vous arrive?*
- *Qu'est-ce qui est important pour vous à connaître ?*
- *Quel niveau d'information souhaitez-vous?*
- *Avez-vous plutôt besoin de beaucoup de détails sur votre situation, ou alors une image plutôt globale ?*

C – Connaissances

Moment de l'annonce: être précis et compréhensible dans le choix des termes. Préférez une annonce par petits bouts assimilables et vérifiez que le patient suit et comprend ce qui lui est dit. Permettez des moments de silence, des moments d'expression et faites preuve d'honnêteté

- *Nous aurions voulu vous annoncer de bonnes nouvelles, mais malheureusement la situation est plus compliquée.*
Laisser ensuite un temps de silence pour évaluer sa réaction. L'information doit ensuite être donnée graduellement en évaluant constamment les réactions du patient et de son entourage, en s'ajustant à leur niveau de compréhension. Une question de type permettant de s'assurer de sa compréhension :
- *Est-ce que vous me suivez ?*

E – Empathie

Adopter une attitude empathique et authentique pour accueillir les émotions du patient afin de légitimer les sentiments

- *Cette nouvelle vous bouleverse et c'est tout à fait compréhensible, nous sommes là pour vous écouter...*
- *Vous semblez totalement abattu par cette nouvelle et c'est tout à fait compréhensible*

S – Stratégies et Synthèse

Identifier les ressources (Comment a-t-il fait face à d'autres situations difficiles dans le passé), les choix thérapeutiques, les craintes, le soutien des proches significatifs (famille, amis, communauté religieuse, assistante sociale...).

Faire la différence entre les problèmes réversibles et irréversibles puis présenter une stratégie qui confirme l'individualité du patient et la spécificité du traitement

Résumer la situation, clarifier les objectifs, le suivi

Clore l'entretien en fixant un prochain rendez-vous et présenter les soutiens à disposition

Il est nécessaire d'évaluer avec le patient s'il est prêt pour une telle discussion, sachant qu'un plan pour la suite, aussi clair que possible, permettra de diminuer son anxiété, qu'au niveau du soutien extérieur dont il peut bénéficier (famille, amis, communauté religieuse, assistante sociale...). Les stratégies de traitement, qu'elles soient curatives ou palliatives, et d'accompagnement doivent être abordées pour que le patient ne se sente pas abandonné. L'ultime phase, comme pour tout autre entretien d'ailleurs, consiste en une synthèse du contenu et du vécu du temps passé ensemble. Elle se conclut par un prochain rendez-vous fixé pour pouvoir reprendre les éléments incompris et répondre aux questions qui émergent fréquemment à distance de l'annonce.

Entretien Structuré : SIMS EASE

S – Situation

1. *Comment allez-vous ? Je viens discuter un moment avec vous, est-ce que ça vous va ?*
2. *Qu'avez-vous compris de la situation jusqu'à présent ?*
3. *Savez-vous pourquoi nous avons réalisé les examens ?*

I – Identification

4. Faire un résumé du contexte
5. *Quel niveau d'information souhaitez-vous ? Voulez-vous beaucoup de détails ou une vue globale ?*

M – Mauvaise nouvelle

6. *J'aurais aimé vous donner de bonnes nouvelles, mais la situation est malheureusement plus compliquée.*

7. *Les résultats des examens ont confirmé...*

S – Synthèse

8. *Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous annoncer ?*

E – Émotions

9. *Comment vous sentez-vous par rapport à cette annonce ?*

10. *Je vois que vous êtes... ce qui est tout à fait normal face à cette situation, je comprends votre ressenti*

A – Aide

11. *Sachez que vous ne resterez pas seul face à cela, nous allons explorer ensemble tout ce qui est possible d'entreprendre dans votre situation*

S – Suivi

12. **Stratégie de suivi :**

- Demander au patient s'il est prêt à parler de la suite
- Demander au patient ce qu'il compte faire pour faire face
- Demander si le patient a des soutiens (famille, amis, etc.)
- Aborder les stratégies de traitement

E – Ending

13. Demander au patient de faire une **synthèse de sa situation**

14. Synthèse finale → **Demander si questions fixer RDV proche et offrir une disponibilité téléphonique** remettre des informations écrites si disponibles **offrir de rencontrer les proches** demander au patient **ce qu'il compte faire le reste de sa journée...**

	Rôle médecin → infirmier	Rôle infirmier → médecin
Avant l'entretien E Environnement intérieur (dossier) extérieur (cf. texte)	Quand planifier l'entretien ? • Je connais le dossier ? Lecture du dossier en entier, correspondance du médecin traitant, définir un projet probable (contact avec le spécialiste: oncologue par exemple) • Qui va parler ? Qui débute l'entretien, répartition du temps de parole, anticiper les émotions: chercher à savoir ce que sait le patient auprès des soignants • A qui je donne mon téléphone ? • Comment je me sens ? Partage avec l'infirmière, au début et à la fin de l'entretien dans un endroit calme	• Quel proche aux côtés du patient ? «On vous propose de faire le point demain avec votre médecin sur votre hospitalisation/sur vos résultats. Je pense que c'est important qu'un proche vous accompagne» • Quelles dispositions ? Salle d'annonce ou chambre seule → autres patients s'absentent → rideaux tirés. Chaises en triangle/rond • Comment je me sens ? Partage avec le médecin <i>avant et après</i> • Patient advocacy. Promouvoir la bonne pratique d'annonce
Pendant l'entretien P Perception du patient	• S'attend-il à ce que je vais lui dire ? Mise à niveau des informations: «Pouvez-vous nous dire ce que vous avez compris jusqu'ici de votre situation ?», «Savez-vous pour quelle raison cet examen a été réalisé ?»	• Identification des représentations liées à la situation de santé : «Vous dites avoir peur, vous arrivez à nous dire de quoi ?» • Perceptions des proches ? «Et pour vous Madame/ Monsieur, vous pensiez à une maladie en particulier ?»
I Invitation	• Que veut-il savoir ? Respect de son rythme de compréhension: «Qu'aimeriez-vous savoir ? Souhaitez-vous connaître les résultats ? Dans le détail ou en général ?» à répéter pendant tout l'entretien (exemple avant la stratégie): «Cela fait beaucoup d'informations, vous me suivez ? Voulez-vous savoir ce qu'on peut faire pour vous aider ? Maintenant ?»	• En cas de refus de savoir ou de vouloir les détails, explorer les raisons de son choix et lui expliciter la possibilité d'en reparler à un autre moment s'il change d'avis: «Avez-vous envie de nous dire ce qui vous retient ? Vous pouvez à tout moment revenir sur votre décision»
C Connaissances	• Je fais l'annonce ? «M. B, ce n'est malheureusement pas la nouvelle que je voulais vous annoncer, mais les examens montrent...». • J'utilise les mots justes ? Nommer la maladie par son nom commun (cancer et non masse, tumeur ou carcinome à petite cellules) • Je laisse du temps au silence juste après l'annonce ? «.....», → permet au patient d'intégrer la nouvelle et aux soignants d'observer les réactions non verbales. Je dis la vérité, je ne minimise pas et je ne dis pas : «Il n'y a plus rien à faire», «arrêt des soins» «petites tâches et petite chimio»	• J'observe les réactions du patient et de ses proches • Je reformule ce que dit (ou n'arrive pas à dire) le patient ? «Ce matin, vous me disiez avoir compris pouvoir guérir de votre maladie, est-ce cela ?» • Je garantis que l'information est donnée graduellement et d'un langage accessible : «J'ai l'impression que cela vous fait beaucoup d'informations. Voulez-vous qu'on continue ? Ou que l'on répète ce que l'on vient de dire ?»
E Empathie	• J'invite le patient et ses proches à nommer ce qu'ils ressentent, je valide leurs émotions, je parle éventuellement des miennes. «Comment vous vous sentez ? Vous avez envie de nous dire ce qu'il se passe à l'intérieur de vous ? Je suis très émue de ce que vous traversez» • J'évite la fausse réassurance : «Rassurez-vous, tout ira bien»	• J'invite le patient et ses proches à nommer ce qu'ils ressentent, je valide leurs émotions, je parle éventuellement des miennes. «Comment vous vous sentez ? Vous avez envie de nous dire ce qu'il se passe à l'intérieur de vous ? Je suis très émue de ce que vous traversez»
S Stratégie et synthèse	• J'aborde les stratégies de traitement curatif et/ou palliatif • Je synthétise le contenu abordé et le vécu exprimé : «Si je résume, l'annonce de ce cancer avancé est une nouvelle très difficile pour vous. L'important pour vous, c'est... De notre côté, nous nous engageons à...» • Questions et prochain RDV : «Avez-vous des questions ? Souhaitez-vous que nous planifions un autre RDV avec vos proches la semaine suivante pour parler de votre décision et répondre à vos questions ?»	• J'identifie les ressources de la personne et les expériences vécues dans le passé où des stratégies efficaces ont été utilisées : «Vous nous avez décrit avant avoir toujours fait face lors de difficultés et être prêt à le faire également dans cette situation» • Je synthétise le contenu abordé et le vécu exprimé : «L'annonce de ce cancer avancé est une nouvelle très difficile pour vous. L'important pour vous, c'est... Vous pouvez compter sur nous...»